

AFMCP 챕터4 | 패널 Q&A; – 식이·생활방식으로 약물 감량

De-prescribing: Dr. Sanjay Bhojraj, Dr. James Carter

1. 임상 케이스: 식이·생활방식으로 약물 감량 사례

케이스	중재	결과
고혈압 3~4제 복용 환자 (저항성 고혈압 의심)	심혈대사 식이 시작 "어지럽거나 두통 생기면 연락하세요, 정기 혈압 측정하세요"	수주 내 약물 감량 필요할 정도로 혈압 하강 → 경고: 너무 빨리 떨어지지 않도록 모니터링
갑상샘 항체 양성 + 갑상샘 약물 복용	항염증 식이 시작	갑상샘 항체 감소 → 갑상샘 보충제 감량 필요
악성 고혈압 + 신경계 에피소드 (요양원 노인) 항고혈압제 부작용: 다리 부종, 연하곤란, 허부종	산화 스트레스·미토콘드리아 기능장애 평가 미토콘드리아 지지 식이 + 단기 보충제 부작용 원인 항고혈압제 중단	혈압 급격히 하강 ("충격적") → 약물 부작용이 오히려 혈압을 더 올리는 경우

2. 약물 감량의 5가지 원칙 (GOTOIT 프레임워크 적용)

원칙	내용
WHY 파악	왜 혈압이 높은가? 왜 지질이 높은가? 왜 인슐린저항성인가? → 근본 원인(수면·스트레스·운동 부재)부터 해결
모니터링	혈압이 너무 빨리 떨어지지 않도록 추적. 약을 감량할 때 저혈압 증상 모니터링
소통	"과잉소통으로 문제 생긴 적 없고, 과소소통으로만 문제 생긴다." 의뢰 의사·협진팀·환자에게 이유, 계획, 주의사항 모두 공유. 차트 software에 quick phrase로 근거·주의사항 기록
GOTOIT	G(Gather)·O(Organize)·T(Tell)·O(Order)·I(Initiate)·T(Track) → 전문의와의 치료 파트너십에도 동일 적용
환자 교육	처방 약물의 근본 원인과 의뢰 적응증 설명. 개인 맞춤형 접근 강조.

3. 감량이 어려운 경우 (주의 사항)

상황	권고
활성 악성 고혈압	안정될 때까지 감량 시도 금기
급성 관상동맥 증후군 직후	지질강하제 감량 대신 유지; 12~18개월 후 재검토
진행된 체장 질환 (석회화·위축)	감량 대상 아님
가족성 고콜레스테롤혈증	지질강하제 감량 지양; 고위험군; 더 심층적 위험 평가 후 환자·팀과 상의

4. 핵심 임상 메시지

- 코어 푸드 플랜 + 파이토뉴트리언트 = 항염증 식이 → 내일부터 시작 가능
- 약물 복용 환자에게 식이 중재 시작 시 → 약물 과잉 투여 위험 모니터링
- 공유 의사결정(Shared Medical Decision Making)은 가이드라인 의무 사항
- 1차 예방(이벤트 전): 생활방식 중재에 적극적, 감량 시도에 자유로움
- 2차 예방(이벤트 후): 근거 기반 지침 준수, 팀과 협력하여 감량